



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : ناهد عبدالوهاب عبدالعاطي سعد

العنوان : 4 ش السلام

الحي / المدينة : شبرا الخيمة

المحافظة : القليوبية

تاريخ تسجيل الإستمارة : 05-10-2026

رقم البطاقة : 27008161400508 رقم التليفون : 01120475672

العمر (تاريخ الميلاد) : 16-08-1970 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإحصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... د/..... د/..... د/..... د/.....

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: ناهد عبدالوهاب عبدالعاطي سعد National ID: 27008161400508	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
مطابق تحقيق الشخصية

تأهيد
عبدالوهاب عبدالعاطي سعد
إش - السلام - ح محمد خميش
شبرا الخيمة أول - القليوبية

٢٧٠٠٨١٦١٤٠٥٠٨

JZ0452032





Name:	ناهد عبدالوهاب عبدالعاطي سعد	
MR. :	5047	
Detailed Medical Report		
		السيد
تحية طيبة وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
2025 NAHT(FEMARA) SIMPLE MASTECTOMY (T2N0/6) 10/2025 MDT :PORTH+FEMARA +ZOMETA 5/1/2026 FEMARA The patient underwent a simple mastectomy for a T2N0/6 breast cancer in October 2025. The multidisciplinary team recommended PORT, FEMARA, and ZOMETA. On 1 May 2026, FEMARA was initiated. END PORT 40 GY/15 FX LAST ONE AT 24/1/2026 FEMARA CALCIUM 1*1*90 ONE ALPHA FOR SM PAUS CXR The patient completed PORT with a total dose of 40 Gy in 15 fractions, with the last fraction delivered on 24 January 2026. FEMARA therapy was continued, and calcium supplementation (1 mg × 1 × 90) was prescribed. One alpha therapy was administered for SM PAUS, and a chest X-ray was ordered. / CT3 N1 >> ER 8/8 PR8/8 her2 0 >> received NAT >>>SM >> ypt2 ypn0 >> PORT today for femara , supp ttt for 3 mn BSM 28-3-2026 >>. free paus , Chest XRAY >> pending A CT staging showed N1 disease with ER 8/8, PR 8/8, HER2 0. The patient received neoadjuvant therapy (NAT) and then underwent surgery (SM). Pathology reported ypT2 ypN0. PORT was administered today for FEMARA, with supportive treatment planned for 3 months of BSM starting 28 March 2026. The patient is on free PAUS, and a chest X-ray is pending. today for zometa only, no app for femara labs accpeted On 16 May 2026, the patient received ZOMETA only; no appointment was made for FEMARA labs, which were accepted. femara +supportive*3m next clinic visit :3/9/2026 On 10 June 2026, FEMARA therapy continued with supportive care for 3 months, with the next clinic visit scheduled for 3 September 2026. A CASE OF BREAST CANCER ON FEMARA TODAY FOR FEMARA FOR 3 MONTH On 2 September 2026, the patient was noted to be on FEMARA for 3 months.		
تحريراً في ,		
	الوقت :	التاريخ : 20-09-2026
	نهى سعيد علي محمد	الطبيب المعالج :
يعتمد ,		

Patient Name: Hoda Abd Al Sadek Al Sayed Youssef

Date : 05/08/2025

Exam : CT CAP(CT Chest Abd. Pelvis)

Age : 74 Year(s)

Medical ID: 2988/2024

Pat. ID: 80470

HODA ABDELSADEK

**MULTISCLICE NON CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS
REVEALED:**

Known case of CA breast.

I- CHEST:

- Mild diffuse right breast skin for sono-mammographic assessment.
- Few subcentimetric left axillary lymph nodes.
- Right middle lobe consolidation is noted.
- Diffuse bilateral scattered reticulo-nodular densities.
- Few bilateral scattered atelectatic bands.
- Right cardiophrenic lymph node measuring 13.2 mm in diameter.
- No pleural or pericardial collection.
- Enlarged cardiac size for echocardiography.
- Bilateral elastofibroma dorsi more evident on the right side.
- The left thyroid lobe is enlarged in size showing a heterogeneously enhancing lesion measuring 43 x 38 mm with retrosternal extension and tracheal shift to the contralateral side. Suspected other smaller right thyroid lobe nodules for sonographic assessment.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Mildly enlarged liver showing homogenous parenchymal attenuation. It shows few ill defined bilobar hypodense hepatic focal lesions largest measuring 16 x 10 mm at segment VII/VIII for triphasic CT study. No dilated biliary radicles.
- The spleen is enlarged in size showing no focal lesions.
- The right kidney shows multiple hyperdense stones largest measuring 3 x 1.3 cm at the renal pelvis. no backpressure changes. Few right renal cortical cysts.
- Left kidney is of normal size, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness. No stones or back pressure changes.
- Multiple subcentimetric para-aortic, mesenteric and peripancreatic lymph nodes.
- Normal plain C.T appearance of the pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- Left adenexal heterogenous lesion is seen measuring 3.5 x 3.6 cm with tiny hyperdense foci seen for MR assessment.

Normal plain CT appearance of the rest of pelvic organs with no pelvic masses or collections.

No ascites.

For better assessment by postcontrast study and PET-CT.

III- Bone Survey:

Few scattered vertebral lytic and sclerotic foci for bone scan.

Lumbar spondylosis with minimal anterolisthesis of L3 over L4 vertebra.

Dr. Sherief Wagdi

09/08/2025 12:55 AM

Signature Dr.Maha Abd El-Karem

09/08/2025 12:57 AM

Name : Huda Abd El-Sadek El-Sayed
Branch : Dokki
Ref.Physician Prof : Gostaf Rosch Hospital

Date : 09-08-2025 10:57
Medical No. : 171274

Tc^{99m} MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

History:

- 73-year-old lady, with right breast cancer, referred for metastatic workup.

Technique:

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post injection of the tracer.

Findings:

- No abnormal active or cold focal bony lesions that may account for metastatic bone disease could be seen all over the surveyed skeleton.
- Degenerative changes are seen at the spine and big joints.

Impression:

- The skeleton is free from metastases.

Best regards,
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear Medicine



Patient Name : السيدة / دة عبد الحادي السيد يوسف
Patient No. : 25108191701127
Form No : SR-1273/24
Sex : Female
Age : 73 Y
Referring Doc :

Request No. : 13007620
Request Date : 04/09/2024
Verification Date : 22/09/2024
Financial Category : فئة اولية
Department : Out Patient
Registered by : Mrs. Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Right breast cancer.
Nature of Specimen: Slide Revision

Gross Examination:

One paraffin block labeled by (5020/24) and 3 slides were received.

Microscopic Examination:

Histological type: Invasive duct carcinoma.

Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): Grade III (3+3+2)

DCIS: No.

Angiolymphatic invasion: No.

Perineural invasion: No.

Additional pathological findings: Poor acinar formation, moderate mitosis and lymphocytic infiltrate 3%.

ER: No nuclear reaction in tumor cells (score 0/8).

PR: Moderate nuclear reaction in 50% of tumor cells (score 6/8).

HER2: Strong complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 3+).

Diagnosis:

Right breast cancer, Slide revision:

Invasive duct carcinoma, Grade III.

ER: Negative (score 0/8).

PR: Positive (score 6/8).

HER2: Positive (score 3+).

Signature

Verified by:

Dr. Sagda El-Kady

Print Date : 28/09/2024 12:33:19

Page 1 of 2

Printing By : mayada.h@pwh.gov.eg

Patient Name : **الاسم / دى عبد الصمدى السيد يوسف**
 Patient No. : **25108191701127**
 Ref No. : **SR-1273/24**
 Sex : **Female**
 Age : **73 Y**
 Referring Doc :

Request No. : **13007620**
 Request Date : **04/09/2024**
 Verification Date : **22/09/2024**
 Financial Category : **المرضى - فئة العامة**
 Department : **Out Patient**
 Registered by : **Mrs.Maysa Hegazy**

Pathology Report

Dr. Salma Tarek
 Dr. Sagda Elkady

Verified by :
 Dr. Sagda El-Kady

Printing Date : 28-09-2024 12:33:19

Page 2 of 2

Printing By : marwa mohamed eldaly



Presidential Programme for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



A-Patient ID:

1- Name: **د. عبد الحليم السيد يوسف** Sex: **Female**

MDT form

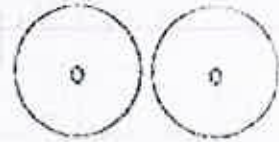
3- Medical number:

83225531

Old Med:

Date: **2024-2024**

2-ID number:

Patient Age: **23 Y**

Family history

None

Phone

Name

01225134026

BMI

Tm

REASON OF MDT

None

marital status

None

NRS Score

None

GROUP

None

Date of MDT

None

Comorbidity

C, P, H, I, D, dm, htn, illd

Menopausal status

None

Initial STAGE

None

27/10/2024

Clinical data

Breast Imaging :

Rt UOQ 3.9*5.9 cm with pathological axillary level 1,2,3 and sev.

Mets Workup :

us:MHEK

mets to hepatic , lung,nodal mets

BX	ER	PR	Her 2 Neu	SISH	Ki67
IOC	0/8	6/8	3		
1x (H&E)	1x (IHC)	1x (IHC)	1x (IHC)	1x (IHC)	1x (IHC)
glin					

T	N	M
cT3	cN3	hepatic , lung,nodal

Sonomammography

PATIENT HISTORY

Denovo mets RT breast to bone, liver and LNs,

MDT OUTCOME & PLAN

PS: 2-3, for Taxol (60mg/m2)/Herceptin IV

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY		RADIOLOGY	
SURGERY		PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	

